ARTICLE · LIPIDES

# Oméga-3 EPA + DHA : votre cerveau en réclame 4 fois plus

*Le déficit nutritionnel le plus invisible des pays développés. Méta-analyses 2024 sur cœur et cerveau.*

VITASYNC · Coach IA santé · vitasync.ai
*Article fondateur · 2026*

# Le déficit nutritionnel le plus invisible des pays développés

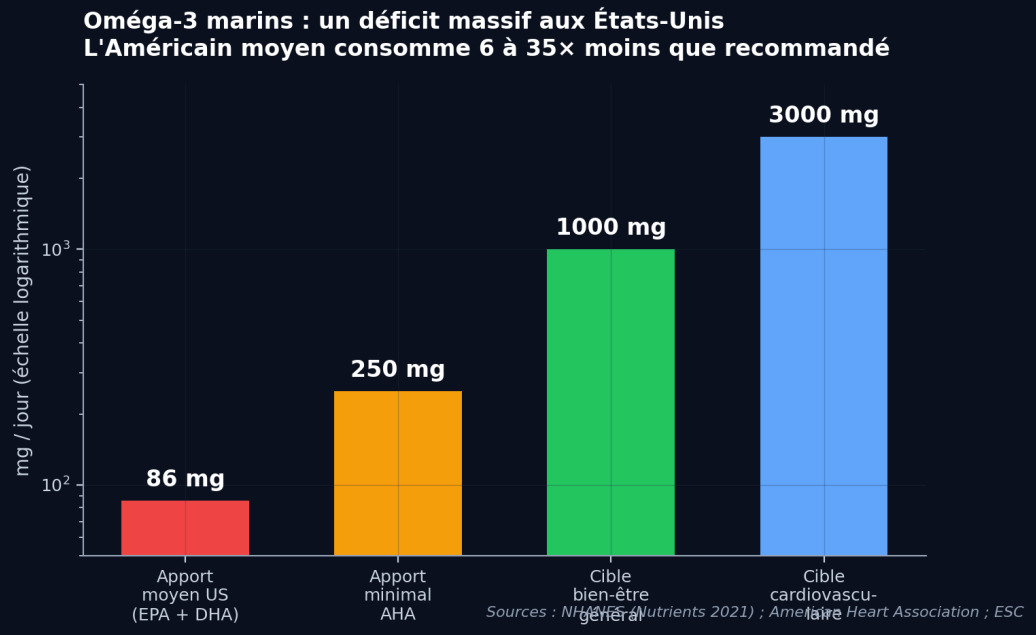
*Quand on parle de carences nutritionnelles aux États-Unis, on pense vitamine D, magnésium, fer. Rarement aux **oméga-3** — et c'est précisément le problème. D'après les données NHANES, l'apport moyen d'un adulte américain est de **63 mg de DHA et 23 mg d'EPA par jour**, soit **86 mg d'oméga-3 marins quotidiens**. Comparé aux **500-1000 mg/jour** recommandés par l'American Heart Association, c'est **6 à 12 fois moins** que le besoin estimé.*

**86 mg**
Apport moyen US (EPA+DHA / jour)

**80 %**
Adultes US sub-optimaux (CDC)

**500+**
mg/j recommandés par AHA

**À RETENIR**
Il existe trois oméga-3 — l'ALA (origine végétale, lin, chia, noix), l'EPA et le DHA (origine marine). Seuls EPA et DHA sont biologiquement actifs ; la conversion ALA → EPA est inférieure à 5 %, et ALA → DHA inférieure à 1 % chez l'humain.




*L'Américain moyen consomme 6 à 35× moins d'oméga-3 marins que recommandé*

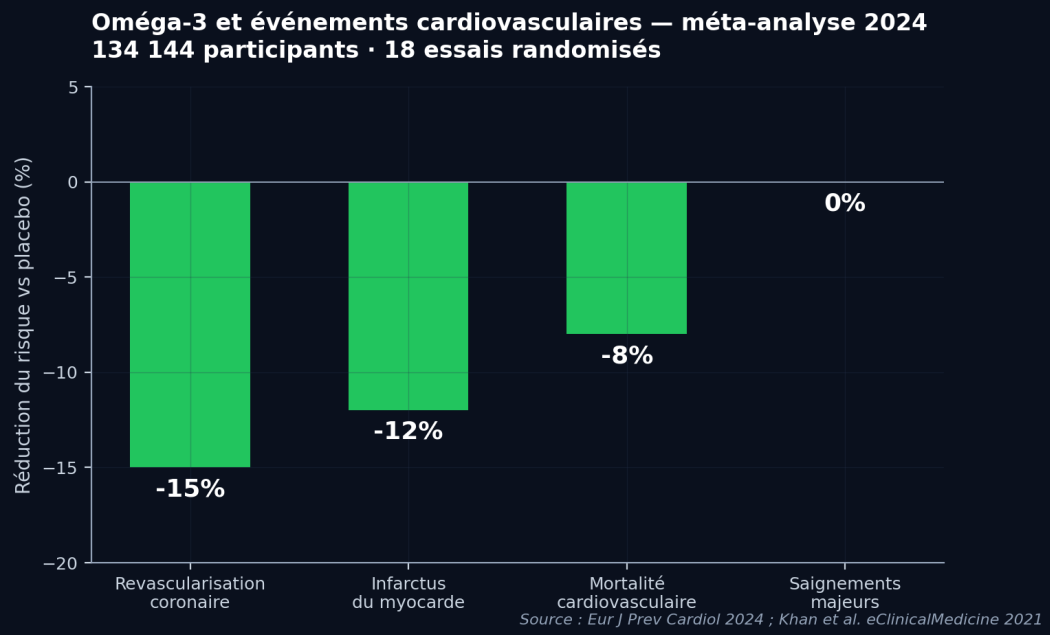
## DHA : le carburant du cerveau

© 2026 VitaSync — Article informatif. Ne remplace pas un avis médical.

Les oméga-3 sont des acides gras polyinsaturés à longue chaîne qui s'incorporent directement dans les membranes cellulaires. Et nulle part ailleurs cette intégration n'est plus dense que dans le cerveau et la rétine. Selon une revue parue dans *International Journal of Molecular Sciences* : le **DHA constitue 40 % des acides gras polyinsaturés du cerveau humain** et **60 % des PUFA de la rétine**. Il participe à la fluidité membranaire, à la signalisation neuronale, et à la modulation de la neuroinflammation.

## Cœur : ce que disent vraiment les méta-analyses 2024

Une **méta-analyse 2024** dans l'*European Journal of Preventive Cardiology* a regroupé **18 essais cliniques randomisés et 134 144 participants**. Conclusions principales : réduction du risque de revascularisation coronarienne, d'infarctus du myocarde, et de mortalité cardiovasculaire. **Pas d'augmentation** du risque de saignement, contrairement à une crainte ancienne.



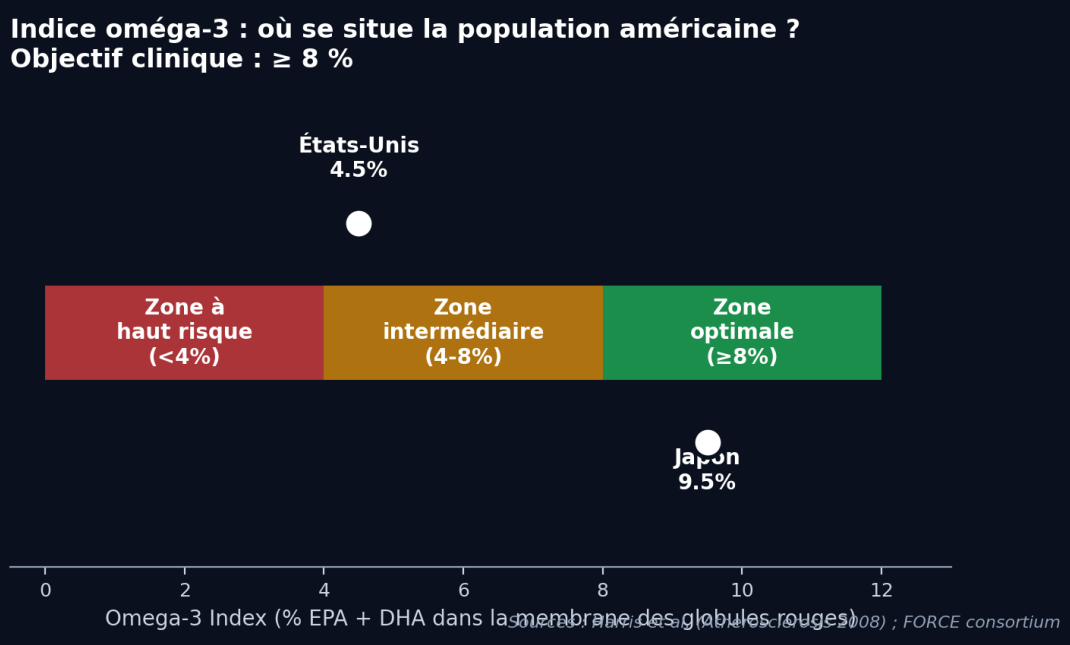

*Méta-analyse 2024 sur 134 144 participants : effets cardiovasculaires des oméga-3*

**NUANCE IMPORTANTE**
L'effet est plus marqué avec l'EPA pure qu'avec un mélange EPA + DHA. L'essai REDUCE-IT (icosapent ethyl, 4 g/j d'EPA) reste la référence cardiologique. L'essai STRENGTH (mélange) avait été interrompu pour futilité. Cela ne signifie pas que le DHA est inutile — il a son propre rôle, principalement neurologique.

## Le fameux Omega-3 Index

L'**Omega-3 Index** est le pourcentage d'EPA + DHA dans la membrane des globules rouges. C'est devenu **le marqueur biologique de référence** pour évaluer le statut oméga-3.

© 2026 VitaSync — Article informatif. Ne remplace pas un avis médical.




*Omega-3 Index : la population US dans la zone à haut risque*

## EPA, DHA ou combiné : comment choisir ?

| Objectif | Forme privilégiée | Dose typique |
|---|---|---|
| Cardiovasculaire (TG hauts) | EPA dominant ou pur | 2-4 g/j |
| Cognition, humeur | DHA dominant | 1-2 g/j (DHA ≥ 60 %) |
| Bien-être général | EPA + DHA combiné (~60/40) | 1-2 g/j |
| Yeux secs, vision | DHA dominant | 1 g/j |
| Inflammation, articulations | EPA dominant | 2-3 g/j |

## Qualité : ce qu'il faut vérifier

**Certification IFOS, GOED ou USP** — garantit l'absence de métaux lourds, PCB et dioxines. **Indice TOTOX < 26** — l'huile rance est inflammatoire au lieu d'être anti-inflammatoire. **Forme moléculaire** — préférer les triglycérides reformés (rTG) ou les phospholipides (krill) plutôt que les esters éthyliques (EE), moins biodisponibles à jeun. **Origine** — petits poissons à courte vie (sardine, anchois, maquereau) = moins de bioaccumulation.

### Le bon ratio EPA/DHA selon votre objectif

Le Coach IA VitaSync analyse votre bilan biologique (PDF), recommande la formulation et le ratio adaptés à votre objectif (cœur, cerveau, articulations), suit vos marqueurs subjectifs et alerte sur les contre-indications médicamenteuses (anticoagulants, chirurgie programmée).

© 2026 VitaSync — Article informatif. Ne remplace pas un avis médical.

→ **Démarrer mon bilan IA gratuit · vitasync.ai**

## Points clés à retenir

• L'Américain moyen consomme **86 mg/j** d'oméga-3 marins, contre **500-1000 mg/j** recommandés.

• Le DHA constitue **40 % des PUFA cérébraux et 60 % des PUFA rétiniens**.

• Méta-analyse 2024 sur 134 144 patients : **réduction de l'IM, des revascularisations et de la mortalité CV**.

• **EPA dominante** est plus efficace pour le cœur ; **DHA** pour le cerveau et la rétine.

• L'Omega-3 Index optimal est ≥ **8 %** — atteignable avec 2-3 g/j d'EPA+DHA en 3-6 mois.

• Privilégier rTG ou phospholipides, certifiés IFOS, TOTOX bas.

## Sources

1. *Importance of EPA and DHA Blood Levels in Brain Structure and Function.* Nutrients, 2021.
2. *The Importance of Marine Omega-3s for Brain Development.* Nutrients, 2020.
3. *Effects of Omega-3 PUFAs on Brain Functions: A Systematic Review.* Cureus, 2022.
4. NIH Office of Dietary Supplements. *Omega-3 Fatty Acids — Consumer Fact Sheet.*
5. *Effects of omega-3 fatty acids on coronary revascularization and cardiovascular events: meta-analysis.* Eur J Prev Cardiol, 2024.
6. *N-3 Fatty Acids and Cardiovascular Health — Updated Review.* Curr Atheroscler Rep, 2025.
7. *Effect of omega-3 on cardiovascular outcomes: meta-analysis.* eClinicalMedicine (Lancet), 2021.

**AVERTISSEMENTS RÉGLEMENTAIRES**
Disclaimer FDA (21 CFR 101.93) — These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Disclaimer médical — Ces informations sont fournies à titre éducatif et ne constituent pas un avis médical. Consultez un professionnel de santé avant toute supplémentation. Disclaimer IA (EU AI Act, Art. 50) — Le Coach IA VitaSync est propulsé par Google Gemini 3 et fournit des informations générales de bien-être, pas un diagnostic médical.